

ΔΗΓΜΑ ΦΙΔΙΟΥ

Γενικά: Εφόσον ειδοποιηθούμε τηλεφωνικώς για συμβάν δήγματος φιδιού, καθησυχάζουμε το θύμα (ή τους οικείους του), ενημερωνόμαστε για το χρόνο και το ανατομικό σημείο του δήγματος, παρέχουμε σαφείς οδηγίες να αποφύγει το περπάτημα ή άλλες άσκοπες ενέργειες και προτρέπουμε το θύμα να παραμείνει ακίνητο, με το πληγέν άκρο σε υπερυψωμένη θέση (γωνία ~ 45°) για να μειωθεί η ιστική βλάβη, μέχρι να διακομιστεί στο ΚΥ ή το νοσοκομείο. Ενίοτε, το θύμα όταν φτάσει στο ΤΕΠ δεν έχει εμφανίσει ακόμα συστηματικά συμπτώματα.

Είδος φιδιού: Στην Ελλάδα τα μόνα δηλητηριώδη φίδια ανήκουν στην οικογένεια των Εχιδνιδών (Viperidae - Οχιές) και είναι σωληνόγλυφα με ισχυρό δηλητήριο, ενώ όσα φίδια ανήκουν στην οικογένεια των Κολουμπρίδων (Colubridae) είναι οπισθόγλυφα με ασθενές δηλητήριο και σχετικώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο (σαπίτης, αγιόφιδιο, δενδρογαλιά).

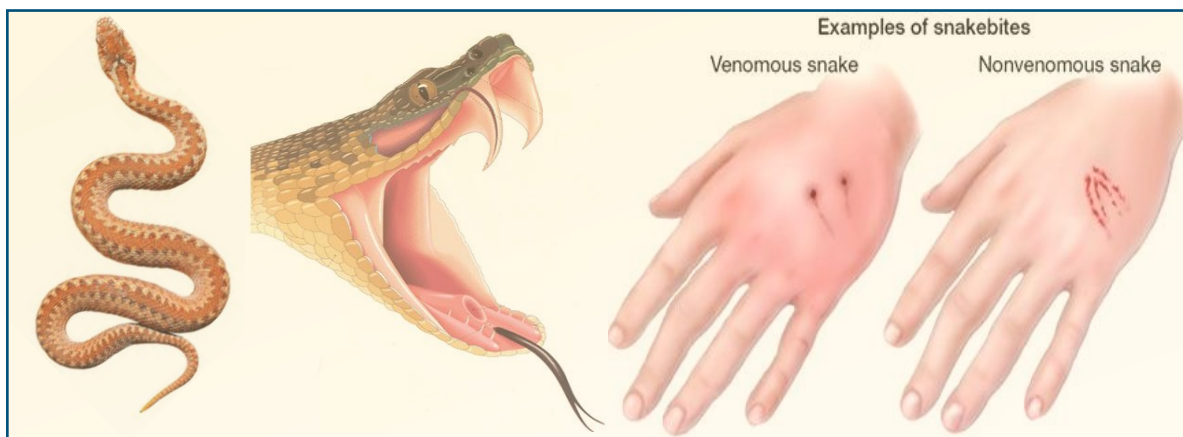
Χαρακτηριστικά, στο σημείο του δήγματος από σωληνόγλυφο φίδι, υπάρχουν δύο οπές με απόσταση 7 mm. Σε κάθε άλλη περίπτωση και εάν το φίδι δεν είναι οχιά, στο σημείο του δήγματος θα μείνει το αποτύπωμα μιας σειράς οδόντων σε σχήμα πετάλου ή ανάποδου "U". Ο οφιδόηκτος συνήθως περιγράφει το φίδι ως οχιά (*Vipera ammodytes*) ή όχεντρα (*Vipera ursini*) ή αστρίτη (*Vipera berus*), οχιά της Μήλου (*Vipera lebetina*), ακουάκι, σαΐτα, κ.λπ.

Ιστορικό: Λαμβάνουμε λεπτομερές ιστορικό για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς και την πιθανή λήψη φαρμάκων για συστηματικά νοσήματα (ΑΥ, ΣΔ, αυτοάνοσο, κ.ά.).

Κλινική εικόνα: **Πρώιμες εκδηλώσεις** είναι ο έντονος καυστικός πόνος, η ερυθρότητα και το τοπικό οίδημα που αναπτύσσονται συνήθως εντός 20-30 λεπτών και ακολουθούνται από αιμωδία της οιδηματώδους περιοχής. Όταν το οίδημα είναι έντονο μπορεί να διαταράξει την τοπική αιμάτωση και να απειλήσει τη βιωσιμότητα ενός μέλους ή τη ζωή του θύματος, ειδικά όταν εντοπίζεται στον τράχηλο ή στο πρόσωπο (*σύνδρομο διαμερίσματος*).

Οι συστηματικές εκδηλώσεις εμφανίζονται εντός 30-120 λεπτών και χαρακτηρίζονται από μεταλλική γεύση, έντονη εφίδρωση, πυρετό, κεφαλαλγία, διπλωπία, ζάλη, ναυτία και έμετο, περιστοματική παραισθησία, αδυναμία, ανησυχία, ταχυκαρδία και υπόταση. Η παρουσία τους υποδηλώνει διασπορά του δηλητηρίου και χαρακτηρίζει τις βαρύτερες περιπτώσεις. Ένδειξη σοβαρής δηλητηρίασης αποτελεί η επέκταση του οιδήματος πάνω από το γόνατο ή τον αγκώνα μέσα σε 2 ώρες ή οι πρώιμα εμφανιζόμενες αιμορραγίες. Η εμφάνιση πυρετού (έως $\Theta = 38,5^{\circ}\text{C}$) θεωρείται ευνοϊκό προγνωστικό σημείο μετά από δήγμα ιοβόλου φιδιού! Οι διαταραχές της πήξης του αίματος, οι οποίες ευθύνονται για τη θνητότητα, οφείλονται στη μείωση του ινωδογόνου και την παράταση του χρόνου προθρομβίνης (PT) και μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT). Ο αριθμός των αιμοπεταλίων παραμένει συνήθως σταθερός.

Η βαρύτητα ενός δήγματος ιοβόλου φιδιού (*Downey score, Snakebite Severity Score-S.S.S.*) εξαρτάται από το σημείο του δήγματος, από τον αριθμό των δηγμάτων, την ποσότητα του αντιγόνου που υπάρχει μέσα στο δηλητήριο, τον χρόνο επαφής των οδόντων του φιδιού με το θύμα, την ευερεθιστότητα του φιδιού (*τα φίδια είναι πιο επιθετικά την Άνοιξη, αμέσως μετά την έξοδο από τη χειμερία νάρκη και κάθε δήγμα εγγχεί περισσότερο δηλητήριο*), κ.ά.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Καθησυχάζουμε τον τραυματία και διατηρούμε και εμείς, φυσικά, την ψυχραιμία μας! Αν εντοπίσουμε στο τραύμα τις χαρακτηριστικές δύο οπές από τα δόντια του φιδιού, τότε μάλλον πρόκειται για δήγμα οχιάς και πρέπει να δράσουμε γρήγορα και μεθοδικά. Ακινητοποιούμε τον ασθενή και ναρθηκοποιούμε ει δυνατόν το πληγέν άκρο, ώστε να μειώσουμε το βασικό μεταβολισμό και την εξάπλωση του δηλητηρίου στον οργανισμό. Χαλαρώνουμε την όποια περίδεση που πιθανώς έχει τοποθετηθεί, ώστε να διατηρηθεί η αρτηριακή κυκλοφορία στο άκρο που δέχθηκε το δήγμα και αφαιρούμε κάθε κόσμημα. Το δηλητήριο ακολουθεί κυρίως τη λεμφική οδό κυκλοφορίας και για αυτό η περίδεση, ειδικά αν είναι ισχαιμική, προκαλεί μεγαλύτερη ζημία (*ιστική βλάβη*) από ό,τι όφελος.
2. Καθαρίζουμε την περιοχή του δήγματος επιφανειακά, με διάλυμα Betadine ή οξυζενέ ή με σαπούνι και νερό, χωρίς όμως να ασκούμε πίεση ή τριβή. Δεν τοποθετούμε τοπικά παγοκύστη ή άλλα ψυχρά επιθέματα, όπως συστήνονταν μέχρι πρόσφατα, αντιθέτως ως γενική αρχή φροντίζουμε ο ασθενής να παραμένει ζεστός. Επίσης, δεν χαράσσουμε την περιοχή του δήγματος, αφού η καταστροφή των ιστών αυξάνει τοπικά την κυκλοφορία και ούτε φυσικά εκμυζούμε με το στόμα το δηλητήριο (*εσφαλμένη λαϊκή δοξασία*)!
3. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία και εκτελούμε ΗΚΓ. (*Αν εμφανιστούν, εφίδρωση, ταχυκαρδία, υπόταση, ναυτία-έμετος, υποθερμία ή ταχέως εξαπλούμενο οίδημα, τότε βρισκόμαστε σε πάλη με το χρόνο*). Εργαστηριακά (γενική και αέρια αίματος, έλεγχος πήξεως, *d-dimers, Urea, Cr, CPK, Amy*). Ελέγχεται τακτικά και σημειώνεται η εξάπλωση του οιδήματος.
4. Τοποθετείται 3-way (#16-18G) φλεβική γραμμή, με 1000 ml N/S και 500 ml D/W 5%. Εάν με τα κρυσταλλοειδή (20-40 ml/kg BΣ) δεν αποκατασταθεί η ΑΠ, τότε χορηγούμε κολλοειδή (*Voluven, Haemaccel*) ή ιδανικά πλάσμα (*FFP*). Επί αποτυχίας των ανωτέρω, χορηγούμε ινóτροπα (iv): 3-10 µg/kg/min Ντοπαμίνη (ήτοι: 4 amp. Giludop 50 mg/5 ml εντός 250 ml D₅W, στις 10-50 μικροσταγόνες), πάντα ανάλογα της διακύμανσης της ΑΠ.
5. Χορηγούμε κλασική Ηπαρίνη (**UFH**) 1 ml (ήτοι 5000 IU) εφάπαξ υποδορίως (sc). Εναλλακτικά, χορηγούμε Ενοξαπαρίνη (**Clexane**) σε δοσολογία 1 mg/kg BΣ (sc). Μπορεί επίσης – αντί της υποδόριας χρήσης κλασικής Ηπαρίνης ή της Ενοξαπαρίνης – να χορηγηθεί υποδορίως (sc) Fondaparinux (**Arixtra**) 1 amp. των 2,5 mg.
6. Χορηγείται ενδοφλεβίως κορτιζόνη, **Lyo-Cortin** (1 amp. 100 mg ή 250 mg ή 500 mg) ή **Lyo-Drol** (1 amp. 125 mg ή 500 mg) αναλόγως βάρους σώματος (BΣ) του ασθενούς.
7. Χορηγούμε 1 amp. **Fenistil** εντός 250 ml NaCl 0,9% (iv), σε διάστημα 20-30 λεπτών.
8. Ανοσοποιούμε με αντιτετανικό ορό (**HTIG**) το θύμα, αν χρειάζεται: inj. **Tetagam-P** (im).
9. Ως γαστροπροστασία, ιδίως σε ασθενείς με ιστορικό έλκους, ΓΟΠΝ ή γαστρορραγίας, χορηγούνται 1-2 amp. Σιμετιδίνη 200 mg (**Tagamet**) διαλυμένα εντός ορού 100 ml N/S ή/και 1 amp. PPIs (**Nexium, Losec, Zureazol**) μετά από ανασύσταση, σε iv-bolus έγχυση.
10. Χορηγούμε ενδοφλεβίως ήπια αναλγητικά (π.χ. Dynastat ή Viaxal, μαζί με Apotel 1 gr), αλλά ουδέποτε Μορφίνη (*προσοχή στα οπιούχα, διότι μειώνουν περισσότερο την ΑΠ*).
11. Διακομίζουμε τάχιστα στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, RR, SpO₂).
12. Σπανίως, χορηγείται ο «**Πολυδύναμος Αντιοφικός ορός Ίππου**», ενδομυϊκώς ή στάγδην ενδοφλεβίως, ήτοι 2-5 amp. των 10 ml εντός διαλύματος 500-1000 ml NaCl 0,9% (*αφού πρώτα ελεγχθεί η ευαισθησία του ατόμου σε αυτόν*), ιδίως σε υποψία δήγματος οχιάς ή αν το δηχθέν σημείο διογκωθεί και μελανιάσει και εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα (*διαταραχές πήξης, νευροτοξικότητα, δεσμιδώσεις, ONA, shock, S.S.Score > 5, κ.λπ.*).
13. Στην περίπτωση στην οποία το φίδι δεν είναι δηλητηριώδες (*άγλυφο ή οπισθόγλυφο*) και ο ασθενής παρέρχεται τον κίνδυνο, χορηγείται προφυλακτικά αντιβίωση, για 5-7 ημέρες:
 - Amoxi/Clav: (**Augmentin/Fugentin**) 1 gr, 1x2 ή 1x3 (po), ή
 - Ciprofloxacin: (**Ciproxin/Ladinin**) 500 mg, 1x2 (po), ή
 - Doxycycline: (**Vibramycin**) 100 mg, 1x2 (po), ή/και
 - Metronidazole: (**Flagyl**) 500 mg, 1x3 (po).

